

宜,前者可通过抑制钙内流而使支气管平滑肌扩张,腺体分泌减少,可能有抗支气管痉挛的作用。(3)伴有糖尿病者,宜选用硝酸酯类及钙拮抗剂,禁用 β 受体阻滞剂,因非选择性 β 受体阻滞剂诱发或掩盖低血糖,选择性 β 受体阻滞剂可使血糖升高。

参考文献

- [1] Flaherty M D. Am J Med 1984; 76 (6A): 52
- [2] Schanzeacher P et al. Am J Cardiol 1985; 55 (1): 33
- [3] Kenneth J et al. N Engl J Med 1984; 310 (26): 1712
- [4] Kaski J et al. Am Heart J 1985;

- 110 (1. part 2): 238
- [5] 余国膺译. 心血管病学进展 1987; 2: 41
- [6] Singh B N et al. Am J Cardiol 1986; 57 (11): 992
- [7] Conti C R. Am J Cardiol 1985; 55 (3): 41B
- [8] David Hoekega et al. Am J Med 1984; 76 (2): 309
- [9] 李文业. 中国循环杂志 1986; 4: 221
- [10] Chatterjee K et al. Am Heart J 1982; 104 (5): 1137
- [11] 胡绍明. 国外医学心血管分册 1984; 4: 209
- [12] 王惠春译. 日本医学介绍 1987; 8 (5): 207

氨茶碱的药物相互作用

衡阳医学院第二附属医院 陈顺烈 林永祥 蒋三员

氨茶碱为平喘药属非线性药物¹,治疗指数窄,大于 $20\mu\text{g}/\text{ml}$ 就可能出现毒性反应²。据报道,本品和多种药物间可能发生相互作用。本文就氨茶碱与其它药物间发生的药物相互作用简述如下。

一、潘生丁

氨茶碱对细胞内破坏环磷腺苷的磷酸二酯酶有抑制作用,从而提高环磷腺苷含量而松弛平滑肌,扩张冠状动脉或支气管。潘生丁则通过抑制腺苷脱氢酶使腺苷降解变慢而促进冠状动脉扩张。两者合用会产生拮抗,不宜合用。

二、麻黄及麻黄素³

氨茶碱和麻黄及麻黄素协同作用,毒性亦增加。且合用并不比单用氨茶碱更有效,不宜常规并用。

三、去甲肾上腺素及肾上腺素⁴

氨茶碱为碱性药物,与去甲肾上腺素或肾上腺素配伍注射会很快失效,故不宜混合注射。

四、新诺明⁵

据报道,4例合用氨茶碱与新诺明的患者,茶碱血药浓度值高,停用新诺明后血药浓度均下降。

五、强的松

据报道,强的松因并用氨茶碱,其生物利用度降低了48%。茶碱的生物半衰期以及生物利用度分别降低了27%和53%。投药时应注意。

六、氯羟安定⁶

氨茶碱可对抗氯羟安定的抑制作用。三例口服或静注氯羟安定的病人术后用氨茶碱催醒后均观察60~90min,未再出现抑制。

七、苯妥因

苯妥因为酶促剂,与茶碱并用可使后者从体内消除。并用时有必要注意增加茶碱的用量。

八、甲氧咪胍⁷

甲氧咪胍对茶碱血浆浓度的影响已在六名患有慢性阻塞性气管疾病而接受茶碱维持疗法的患者中作了研究。结果表明,茶碱的消除率平均下降25%,从而导致茶碱的血浆

浓度增高,可发生中毒。应避免并用,必要时,应监测茶碱的血药浓度。

九、青霉素

含青霉素G钾的5%葡萄糖输液中加入氨茶碱注射液,能使混合液的 $\text{pH} > 8$ 左右,使青霉素分解而降效,该输液应在3~4 h内用完。

十、庆大霉素⁸

氨茶碱会使庆大霉素容易重吸收,抗菌效力增强,尿液碱化后,庆大霉素使用于杆菌性尿道炎病人,只需原剂量的1/5就有效果,同时可减轻庆大霉素的毒性反应。

十一、呋喃咀啉

呋喃咀啉在酸性条件中抗菌力强,氨茶碱可碱化尿液,二者同时服用,可使呋喃咀啉降效。

十二、咖啡因¹⁰

咖啡因通过竞争相同的酶系和受体而加速茶碱的消除,缩短半衰期。其临床意义是长期饮用含咖啡因的饮料,因减弱茶碱的疗效而需增量,反之,停用上述饮料时,又会因茶碱过量而中毒。

十三、氯霉素

氯霉素与氨茶碱混合静脉滴注治疗肺心

病时由于氯霉素的酶抑作用而影响氨茶碱在肝内的代谢,尤其是长期联合使用,茶碱的治疗血药浓度就不易控制,毒副作用容易发生。如果必须合用,应控制剂量,进行血药浓度监测。

十四、心得安¹⁰

茶碱中毒者血浆茶碱浓度与血糖升高、血钾降低有关。低钾血症可增加茶碱产生严重心律失常的危险。并用心得安可纠正低钾血症和高血糖症,改善血流动力学,因此,心得安对茶碱中毒病人是有益的。

参考文献

- [1] 莫念来.药学报 1983; 18(2): 152
- [2] 李汉蕊等.药学报 1986; 21(10): 597
- [3] 张淑芳等.中国医院药学杂志 1986; 6(3): 1, 6
- [4] 陈新谦主编.新编药理学.第十二版.北京:人民卫生出版社, 1985: 362, 365.
- [5] 夏培源.中国医院药学杂志.1985; 5(6): 9
- [6] Wangler A et al. Anesth Analg 1985; 64(8): 834
- [7] The Australian J of Pharmacy 1984; 65(772): 557
- [8] 毛凤斐等.医院药学杂志 1981; (1): 46
- [9] Kozak P P et al. J Allergy Clin Immunol 1977, 60: 149
- [10] Amin DN et al. Lancet 1985; 1: 520

西米替丁与异搏定的药物相互作用

中国人民解放军第371医院 申庆亮

已知西米替丁与心得安¹、利多卡因²、茶碱³等药物并用时,使这些药物体内消除减慢。推测此作用是因为服用西米替丁引起肝血流量减少,并抑制肝药物代谢酶细胞色素P-450的活性。

异搏定是用于急性心律不齐及心绞痛的钙拮抗剂,其代谢是以细胞色素P-450为催化酶。另外也有报告受到肝血流量的变化的影响。因此,可以预料由于与西米替丁并

用而引起药物相互作用。

曾用⁴9名健康男性(年龄从18~40y),试验第1 d用吲哚花青绿测定肝血流量,第2 d静脉注射10mg异搏定,定时采集血样,用气相色谱仪测定异搏定的血中浓度。被试者停药2 d,从第5 d到第9 d的5 d内,每d 4次口服300mg西米替丁,第9 d再次测肝血流量。次日晨服用西米替丁300 mg 1 h后,静脉注射10mg异搏定,与第2 d